УРОК 26. ХРОНИЧЕСКИЙ ТОНЗИЛЛИТ: СХЕМА РАБОТЫ. СУСТАВЫ. ОСТЕОПОРОЗ. СХЕМА РАБОТЫ.

ТОНЗИЛЛИТ

Тонзиллит – воспалительное заболевание, поражающее небные миндалины. Острая форма болезни имеет инфекционную природу и воздушно-капельный путь передачи, проявляется воспалением лимфоглоточного кольца. Развивается в результате инфицирования вредоносными бактериями, грибковыми возбудителями и вирусами.

Тонзиллит характеризуется гиперемией, покраснением и болью, в некоторых случаях появлением гнойного содержимого в лакунах или всех миндалинах.

ОСЛОЖНЕНИЯ ТОНЗИЛЛИТА:

- гнойное воспаление тканей ротоглотки;
- воспаление легких;
- воспаление среднего уха;
- снижение слуха.

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ТОНЗИЛИТА

В слизистые оболочки лимфа сбрасывает «труппы» патогенных микроорганизмов и токсические метаболиты.

Если в организме присутствует:

- грибковая;
- паразитарная;
- вирусная;
- бактериальная инфекция,

то лимфоузлы сразу включаются в работу по увеличению лимфоцитов, которые нейтрализуют инфекцию. Далее лимфатическая система выводит переработанный материал в кожу и слизистые оболочки организма (верхние дыхательные пути, ротоглотка, слизистые влагалища, эндометрия, кишечника).

Слизистые кишечника – эта самая большая площадь для очищения лимфы и место выброса ядов из организма. Кишечник выстилают тысячи лимфоузлов (в ЖКТ расположено больше всего лимфоузлов).

При наличии проблем с кишечником (запоры, вздутия, брожения), то лимфа очищаться полноценно через слизистые кишечника не может, вследствие чего, лимфатическая система ищет другие пути очищения и «гонит» лимфу дальше, подключая кожу или другие слизистые оболочки.

В результате могут перегружаться:

- носо-/ротоглотка, что приводит к отечности тканей, повышенной предрасположенности к инфекциям, гаймориту, ангине, тонзиллиту, образованию аденоидов;
- яды могут складироваться в молочных железах, что может привести к мастопатии;
- перегружаются потовые железы, отсюда резких запах пота или усиленное потоотделение;
- перегружаются лимфоузлы этих областей, скапливается секрет, появляется отек, повышается риск воспаления лимфоузлов.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТОНЗИЛЛИТА

1. РАБОТА С ПИТАНИЕМ.

Рацион человека напрямую влияет на состояние ЖКТ, лимфатической системы, на состав микрофлоры в ЖКТ, миндалинах и на иммунные защитные силы организма.

Продукты, провоцирующие воспалительные процессы в миндалинах:

- мучные изделия (в том числе и бездрожжевые), глютен;
- шлифованные крупы с высоким содержанием крахмала: белый обработанный рис, овес, кукуруза, манная крупа, булгур;
- картофель;
- вы молочные продукты (кроме сливочного и топленного масла);
- все сладкие продукты (в основе практически каждого тонзиллита и ангин лежит грибковая нагрузка);
- термически обработанные растительные масла (подсолнечное и кукурузное).

Исключение или ограничение этих продуктов питания является основой для лечения или профилактики хронического тонзиллита.

Без коррекции питания лечение тонзиллита будет иметь временный характер.

2. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ КИШЕЧНИКА и РАБОТА С ЖКТ.

- ежедневный стул минимум 1 раз в день до полного опустошения кишечника;
- здоровый микробиом кишечника.

В рационе на регулярной основе должны присутствовать сырые овощи, зелень, квашенная капуста, ягоды.

Работа с желудком, печенью, желчеоттоком, дисбиозом.

3. РЕГУЛЯРНОЕ ПРОМЫВАНИЕ МИНДАЛИН.

Нужно регулярно вымывать «пробки» в лакунах миндалин.

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ ГОРЛА:

- 1 ч.л. соды на стакан воды (содовый раствор);

- 10 капель перекиси водорода на стакан воды;
- 1 капсула Аргент Макса на 100 мл воды.

Полоскать горло 3 раза в день.

4. **ПРИЕМ ЙОДА НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ** (либо в суточной дозировке, либо в дозировке исходя их дефицита йода).

Йод – мощный антисептик, хорошо подавляет рост грибковой, бактериальной микрофлоры, снижает вирусную активность в организме.

СУСТАВЫ

Артрит – это воспалительный процесс в суставах.

Артроз – это заболевание хронического типа, при котором в результате нарушения обменных процессов происходит прогрессирование дегенеративно-дистрофических изменений в суставных структурах, с постепенным разрушением хрящевой ткани и суставов.

ДИАГНОСТИКА: МРТ и рентген.

СХЕМА РАБОТЫ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУСТАВОВ

(артриты, артрозы)

1. РАБОТА С ПИТАНИЕМ.

ВОСЕМЬ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ НУЖНО ИЗБЕГАТЬ ПРИ БОЛЯХ В СУСТАВАХ (любого характера: воспалительного, дегенеративного, аутоиммунного):

1. Сахар, т.к. он провоцирует воспаление, стимулируя появление цитокинов – гормонспецифических белков, отвечающих за реакции воспаления. Плюс, избыток сахара в рационе приводит к увеличению веса и дополнительной нагрузки на суставы.

2. Красное мясо, субпродукты, бульоны, т.к. данные продукты содержат в избытке пурины, которые активно травмируют суставные ткани и усиливают воспаление.

3. Любой алкоголь, который усиливает реакции в суставах, особенно в сочетании вина и мяса. Вино и пиво содержат особо много пуринов, которые превращаются в организме в мочевую кислоту, которая травмирует суставные ткани (под микроскопом имеет структуру битого стекла) и вызывает острые подагрические боли.

4. Молочные продукты, т.к. молочные белок – известный триггер любых аутоиммунных процессов.

5. Дрожжевая выпечка. Поврежденные суставы иногда повреждены грибковой инфекцией. Кандида не только может жить в кишечнике и половых органах, но также и в суставах. Дрожжи содержат пурины, что также приводит к воспалению суставов.

6. Кукурузное, арахисовое, подсолнечное масло усугубляет имеющиеся воспалительные процессы за счет повышенного содержания в них омега-6 жирных кислот.

7. Поваренная соль, задерживает жидкость в суставах.

8. Шоколад, кофе, черный чай, какао также содержат пурины, которая превращается в процессе метаболизма в мочевую кислоту, повреждающую суставы.

2. **ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ СХЕМА** (урок про биохимический анализ крови) 3-4 курса в год по 2 месяца.

+ прием Босвелии (2 капсулы по 500 мг 2 раза в день, курс - 2 месяца).

3-4 курса в год.

Лечебные свойства растения босвелии используются в следующих случаях: при заболеваниях суставов – артритах, ревматизме, остеохондрозе, подагре, ревматоидном артрите, при болях в спине, при повышенных нагрузках на опорно-двигательный аппарат, сохраняет подвижность суставов и гибкость мускулов, снимает боли и опухоли в суставах. В Индии ее называют «борцом с воспалениями».

3. **СУСТАВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ –** самые лучшие комплексы упражнений доктора Евдокименко (следует ограничивать упражнения с собственным или дополнительным весом, упражнения выполняются без нагрузки на суставы, ходьба при артрозах или коксартрозах ограничивается до 5 000 – 7 000 шагов в день).

https://www.youtube.com/watch?v=yemp5WnpZrw&list=PLL0pkICOrNuL6ceEgC5UvbVnrYv9Kblv0

Упражнения при коксартрозе с вытяжением

https://www.youtube.com/watch?v=e8LKfZlg7ow&t=584s

Суставные упражнения укрепляют мышцы и снимают нагрузку с суставов. Суставы укрепляются, улучшается метаболизм в них, суставы освобождаются от избыточных солевых отложений, улучшается подвижность сустава, замедляется или приостанавливается процесс разрушения сустава, снимается боль.

Рекомендуется чередовать данные упражнения.

4. **РАБОТА С ДЕФИЦИТАМИ по чек листу.** Проверить дополнительно витамин B3 и витамин B5, т.к. дефициты этих витаминов могут приводить к болям в суставах, кальций, витамин D3.

ОСТЕОПОРОЗ

Остеопороз – это состояние, при котором снижается плотность костной ткани, с появлением ее хрупкости и склонности к патологическим переломам. Иными словами, остеопороз – это повышенная «пористость» скелета.

СИМПТОМЫ ОСТЕОПОРОЗА:

- уменьшение роста человека;
- чрезмерная сутулость;
- сильные боли в нижних отделах спины;
- частые переломы костей (позвонки, шейка бедра и лучезапястная кость);
- боль в грудном и поясничном отделах, возникает эта боль в результате длительных статических нагрузок (то есть при сидячей работе и пр.);
- судороги ног в ночное время;
- ногти становятся хрупкими, подвергаются расслоению, как и волосы.

Остеопороз – не всегда возрастная проблема, костную ткань человек может терять в любом возрасте.

У мужчин за плотность костной ткани отвечает тестостерон, у женщин – эстрогены и прогестерон.

ПРИЧИНЫ ПОТЕРИ КОСТНОЙ ТКАНИ:

- адинамия;
- дефицит минералов (кальций, магний, бор) и витамина D3;
- чрезмерное употребление сладкого, углеводов и фосфатов (сладкая газировка);
- злоупотребление алкоголем и курение;

- проблема с ЩЖ и паращитовидными железами;
- дефицит половых гормонов (эстроген, прогестерон, тестостерон), ДГЭА.

ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА:

- анализ крови: кальций общий, витамин D3, фосфор, паратгормон, щелочная фосфатаза;

- анализ мочи: деоксипиридонолин (ДПИД) – маркер резорбции костной ткани;

- денситометрия – аппаратное исследование плотности костей, позволяет оценить потерю костной плотности с точностью 95-99% и диагностировать развитие остеопороза на самых ранних стадиях + отслеживать динамику лечения;

- рентген. На рентгеновском снимке остеопороз будет заметен лишь тогда, когда потеряно уже 20-30 % костной массы.

ВНИМАНИЕ: остеопороз отлично поддается лечению при закрытии дефицита витамина D, кальция, фосфора, магния, марганца, бора, меди, цинка, витамина С
+ дефицитов по чек листу;
+ работа с ЖКТ;
+ работа с гормональным фоном (половые гормоны, щитовидная железа);
+ коррекция питания;
+ режима сна и физической активности.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Что такое тонзиллит.
2. Какие осложнения могут возникнуть при тонзиллите?
3. Назовите главную причину тонзиллита.
4. Какие продукты исключаются при работе с тонзиллитом?
5. Как работать с тонзиллитом, помимо питания?
6. Что такое артрит и артроз?
7. Какие продукты следует исключить при работе с заболеваниями суставов?
8. Что входит в противовоспалительную схему работы с заболеваниями суставов?
9. Почему важны упражнения для суставов? В чем их польза?
10. Какие витамины нужно дополнительно проверить при заболеваниях суставов?
11. Что такое остеопороз?

12. Назовите симптомы остеопороза.
13. Назовите причины остеопороза.
14. Как можно диагностировать остеопороз?
15. Как работать с остеопорозом?